

فین تک سلامت - تأمین مالی زنجیره دارو

دارونقدی

نقد کردن طلب داروخانه از بیمه، ظرف ۴۸ ساعت

پروپوزال راه اندازی پلتفرم تأمین مالی مطالبات داروخانه های خصوصی ایران: تبدیل طلب تأیید شده سازمان های بیمه گر به نقدینگی عملیاتی، بدون وثیقه ملکی و بدون توقف قفسه دارو.

موضوع

فکتورینگ نسخه ای و سیستم عامل نقدینگی داروخانه

مخاطب سند

شریک بانکی، سرمایه گذار و هیئت مؤسس

بازار هدف سال اول

داروخانه های سرپایی خصوصی تهران و اصفهان

مدل درآمد

کارمزد تنزیل + اشتراک نرم افزار

این سند صرفاً برای بررسی داخلی تهیه شده است. ارقام بازار بر اساس اظهارات انجمن داروسازان ایران و گزارش های خبری تابستان ۱۴۰۵ است و باید پیش از جذب سرمایه با داده عملیاتی به روز شود. دارونقدی نهاد اعتباری نیست و فقط از مسیر بانک یا نهاد مالی دارای مجوز فعالیت می کند.

فهرست مطالب

1. خلاصه مدیریتی
2. صورت مسئله
3. راه حل محصول
4. سفر مشتری و قابلیت ها
5. اندازه بازار
6. مدل کسب و کار و قیمت گذاری
7. رقبا و تمایز
8. مسیر قانونی و شرکا
9. ورود به بازار
10. نقشه راه و تیم
11. سناریوی مالی
12. ریسک ها، کنترل ها و درخواست

۱. خلاصه مدیریتی

داروخانه ایرانی دارو را تقریباً نقد از پخش می خرد و سهم بیمه را چهار تا هشت ماه بعد می گیرد. نتیجه این شکاف، قفسه خالی، چک برگشتی و کمبود کاذب دارو برای بیمار است. تا مرداد ۱۴۰۵ رئیس انجمن داروسازان ایران حجم مطالبات داروخانه ها از بیمه ها را حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بیش از ۱۸ هزار داروخانه سرپایی خصوصی حدود ۸۰ درصد خدمت دارویی کشور را می دهند.

دارونقدی این طلب را وام شخصی نمی کند. نسخه های تأیید شده را بسته بندی می کند، بانک عامل ۸۵ تا ۹۲ درصد ارزش را ظرف ۴۸ ساعت می پردازد، و وقتی بیمه تسویه کرد اصل برمی گردد. نرم افزار کنار پول، چک پخش و کسورات نسخه را مدیریت می کند تا داروخانه در محصول بماند.

۴۸ ساعت

هدف نقدشوندگی دارونقدی

۴ تا ۸ ماه

تأخیر معمول وصول

۷۷ همت

طلب اعلام شده از بیمه ها

۱۸ هزار+

داروخانه سرپایی خصوصی

پیشنهاد اجرایی: پایلوت ۹۰ روزه با یک بانک عامل و ۲۰ داروخانه در تهران. اگر نرخ وصول و رضایت پخش تأیید شد، ظرف ۱۲ ماه به ۱۵۰ داروخانه و سپس به اصفهان و مشهد گسترش داده می شود. سرمایه بذر عمدتاً صرف محصول داده، اتصال نسخه الکترونیک و تیم عملیات می شود؛ ترازنامه وام روی دفاتر دارونقدی نمی آید.

۲. صورت مسئله

چرخه معیوب نقدینگی

داروخانه آخرین حلقه زنجیره دارو است، اما بدترین موقعیت نقدی را دارد. شرکت‌های پخش در شرایط فشار، تسویه را کوتاه یا نقدی کرده‌اند؛ بعضی سهمیه را به چک پای‌بار یا حتی پرداخت نقد گره زده‌اند. از آن سو سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح سهم خود را با تأخیر چندماهه می‌پردازند. سهم ارز و طرح دارویار هم جداگانه عقب می‌افتد. داروخانه مجبور است «نقد بخرد و نسبه بفروشد».

حلقه	رفتار مالی امروز	فشار روی داروخانه
تولید و واردات	نیاز به تسویه نسبتاً سریع از پخش	غیرمستقیم؛ کمبود در مبدأ
شرکت پخش	کاهش مهلت، چک صیادی، قطع سهمیه	نیاز فوری به ریال برای پر کردن قفسه
داروخانه خصوصی	فروش بیمه‌ای بدون دریافت همان‌روز	سرمایه در گردش ماه‌ها قفل می‌شود
بیمه‌گر پایه	پرداخت ۴ تا ۸ ماهه، گاهی با کسورات	عدم قطعیت زمان و مبلغ خالص

شواهد بازار (تابستان ۱۴۰۵)

- مطالبات داروخانه‌ها بابت سهم بیمه و ارز دارو در گزارش‌های انجمن از حدود ۵۲ همت در تیر به ارقام بالاتر در مرداد رسیده و رقم ۷۷ همت نیز اعلام شده است.
- تأخیر تأمین اجتماعی در سهم بیمه تا حدود ۷ ماه و در سهم ارز حدود ۴ ماه گزارش شده است.
- حدود ۸ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده؛ نشانه بحران نقدینگی است نه فقط حسابداری.
- همکاری ماهانه داروخانه‌ها با تأمین اجتماعی حدود ۱۲ همت ذکر شده؛ پرداخت‌های مقطعی فاصله را پر نمی‌کند.

چرا این راه‌ها کافی نیست

- وثیقه ملکی با چرخه نسخه بی‌ربط است
- پوز فقط بخشی از فروش را می‌بیند
- پخش دیگر حاضر به استمهال گسترده نیست
- کمبود کاذب به بیمار و نظام سلامت می‌رسد
- داروخانه کوچک زودتر از زنجیره می‌میرد

آنچه داروخانه امروز می‌کند

- وام با ضامن و سند
- وام روی کارتخوان (گردش پوز ≠ طلب بیمه)
- نسبه اجباری از پخش تا حد ممکن
- کاهش موجودی داروهای گران
- گاهی انصراف از تمدید قرارداد بیمه

سامانه فکتورینگ وزارت اقتصاد برای مطالبات قراردادی پیمانکاران طراحی شده، نه برای هزاران نسخه الکترونیک روزانه یک داروخانه محله. این شکاف محصول است، نه فقدان قانون.

۳. راه حل محصول

دارونقدي يك سيستم عامل نقدينگي داروخانه است با هسته تأمين مالي: فقط طلبي را پيش خريد مي كند كه در سامانه بيمه گر قابل استناد و تا حد ممكن تأييد شده باشد. پلتفرم پول مردم را نمي گيرد، سپرده نمي سازد و نرخ غيرمجاز نمي فروشد. بانك يا نهاد فكتورينگ داراي مجوز، خريد دين مي كند؛ دارونقدي داده، بسته بندي ريسك، وصول و نرم افزار عمليات را مي سازد.

جمله ارزش

«نسخه تأييد شده را امروز نقد كن؛ وقتی بيمه پرداخت كرد تسويه مي شود. همزمان بين كدام چك پخش را بايد اول بپردازي تا سهميه قطع نشود.»

معماري نقش ها

نقش	كار	آن چه نمي كند
داروخانه	اتصال نرم افزار، انتخاب بسته هاي قابل تنزيل، تسويه با پخش	وثيقه ملكي براي اين محصول
دارونقدي	استعلام نسخه، امتيازدهي كسورات، قرارداد ديگيتال، كارتابل رد، پيش بيني چك	نگه داشتن وام روي ترازنامه خود
بانك / نهاد مالي	تأمين وجه، خريد دين، حساب اماري وصول بيمه	عمليات ميداني داروخانه
بيمه گر	پرداخت طبق روال موجود به حساب معرفي شده	تغيير قانون؛ فقط مسير تسويه شفاف مي شود

آن چه تنزيل مي شود و آن چه نمي شود

قابل خريد در نسخه يك

- نسخ الكترونيك تأمين اجتماعي با وضعيت تأييد / قابل پرداخت
- سقف تعهد براي هر داروخانه و هر ماه
- ذخيره كسورات از روي تاريخچه همان داروخانه

عمداً خارج از نسخه يك

- سهم ارز و دارويار (رديابي جدا، ريسك بودجه اي جدا)
- نسخه در وضعيت نقص مدرک يا اعتراض باز
- طلب كلينيك و بيمارستان (فاز دو)

۴. سفر مشتری و قابلیت‌ها

۱. **اتصال.** داروخانه با شناسه صنفی و قرارداد بیمه ثبت‌نام می‌کند. نرم‌افزار داروخانه یا فایل دوره بیمه به پنل وصل می‌شود.

۲. **شفاف‌سازی طلب.** مطالبات به تفکیک تأمین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح، سهم فنی و سهم ارز دیده می‌شود. نسخ ردشده جدا می‌ماند.

۳. **پیشنهاد قیمت.** سیستم درصد قابل‌پرداخت، ذخیره کسورات، کارمزد تنزیل و مبلغ خالص ۴۸ ساعته را نشان می‌دهد. داروخانه یک‌کلیک قبول می‌کند.

۴. **پرداخت.** بانک عامل خالص را به حساب داروخانه واریز می‌کند. حق وصول طلب به مسیر قراردادی بانک منتقل می‌شود.

۵. **عملیات قفسه.** پنل پیشنهاد می‌دهد کدام فاکتور پخش و کدام چک صیادی را با این پول تسویه کند.

۶. **وصول.** واریز بیمه با بسته تطبیق می‌شود. کسورات از ذخیره کسر می‌گردد. مابه‌التفاوت طبق قرارداد بسته می‌شود.

ماژول‌های نرم‌افزاری (قفل رقابت)

ماژول	کارکرد	چرا داروخانه می‌ماند
دفتر کل طلب بیمه	وضعیت هر دوره و هر نسخه	جایگزین اکسل و پیگیری تلفنی
موتور کسورات	پیش‌بینی درصد رد بر اساس تاریخچه	غافلگیر نشدن در تسویه نهایی
کارتابل رفع نقص	نسخه ناقص همان روز اصلاح شود	طلب «سوخت‌شده» کم می‌شود
تقویم چک پخش	تطبیق سررسید صیادی با واریز تنزیل	کاهش برگشت چک
گزارش بانک	بسته ریسک، تخلف و سقف درگیری	بانک بدون این گزارش پول نمی‌دهد

اگر فقط فکتورینگ خام فروخته شود، واحد اعتبار بانک بعداً کپی می‌کند. چسبندگی در داده نسخه، پیش‌بینی کسورات و نجات چک پخش است.

۵. اندازه بازار

بازار قابل دسترس، موجودی مطالبات معوق نیست؛ جریان ماهانه نسخ بیمه‌ای داروخانه خصوصی است که بارها در سال قابل تنزیل است. اگر همکاری ماهانه با تأمین اجتماعی حدود ۱۲ همت باشد و سلامت و نیروهای مسلح به آن اضافه شود، جریان سالانه طلب داروخانه‌ای کشور در مقیاس صدها همت قرار می‌گیرد. حتی سهم کوچک این جریان، کسب‌وکار بزرگی است.

لایه	تعریف	برآورد اولیه
کل بازار مسئله (TAM)	جریان سالانه سهم بیمه داروخانه‌های سرپایی خصوصی	بیش از ۱۵۰ همت در سال (با احتیاط؛ نیازمند داده بانکی)
بازار قابل خدمت (SAM)	داروخانه خصوصی تک‌شعبه و ۳ تا ۱۰ شعبه در کلان‌شهرها با قرارداد بیمه فعال	حدود ۸ تا ۱۰ هزار داروخانه
هدف واقع‌بینانه ۳۶ ماهه (SOM)	۸۰۰ تا ۱۲۰۰ داروخانه فعال روی پلتفرم	حدود ۵ تا ۸ درصد SAM تعدادی

واحد اقتصادی یک داروخانه نمونه

زنجیره‌های بزرگ خودشان با بانک حرف می‌زنند. مشتری ایده‌آل سال اول، داروخانه خوب اما تحت فشار پخش است؛ جایی که مدیر داروساز هر هفته برای پاس کردن چک تصمیم می‌گیرد.

داروخانه متوسط شهری ممکن است ماهانه ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سهم بیمه قابل استناد داشته باشد (بسته به محل و ترکیب نسخه). با تأخیر ۶ ماهه، چند میلیارد تومان سرمایه در گردش در هواست. همین عدد برای داروخانه، مسئله بقاست نه «بهینه‌سازی مالی».

ارقام TAM باید در پایلوت با داده واقعی ۲۰ داروخانه کالیبره شود. در ارائه به بانک، به‌جای همت کل کشور، متوسط نسخه تأییدشده هر داروخانه و نرخ کسورات تاریخی را نشان بدهید.

۶. مدل کسب و کار و قیمت گذاری

دو موتور درآمد

موتور	منطق	نقطه شروع پیشنهادی
کارمزد تنزیل / origination	سهم از کارمزد بانک بابت فاصله زمانی تا وصول	۱۵ تا ۲۵ درصد کارمزد بانک، یا ۰/۴ تا ۰/۸ درصد مبلغ اسمی به ازای هر ماه انتظار
اشتراک پنل	داروخانه‌ای که حتی تأمین مالی نگیرد، دفتر طلب و چک می‌خواهد	۱/۵ تا ۳ میلیون تومان در ماه، با تخفیف در صورت تنزیل فعال

منطق قیمت برای داروخانه

نرخ باید از نزول غیررسمی و از هزینه برگشت چک ارزان‌تر باشد، و از «صبر کردن برای بیمه» گران‌تر به نظر نرسد. ارزش واقعی نجات سهمیه انسولین و جلوگیری از برگشت چک است، نه اختلاف چند واحد درصد. در گفتگو با داروساز باید به زبان قفسه حرف زد: «این ماه سه چک پخش‌ات پاس می‌شود.»

مثال توضیحی (غیرتعهدآور): بسته ۲۰۰ میلیون تومانی نسخ تأییدشده تأمین اجتماعی، متوسط انتظار ۶ ماه. بانک معادل حدود ۸۸ تا ۹۲ درصد را نقد می‌پردازد. اگر کل هزینه تأمین مالی برای داروخانه معادل ۲ تا ۳ درصد در ماه باشد، در برابر خواب ۶ ماهه سرمایه و ریسک قطع سهمیه، تصمیم Rational است. سهم دارونقدی از این کارمزد است، نه بهره جداگانه روی داروخانه.

آنچه فروخته نمی‌شود

- سود ماهانه تضمینی به داروخانه بدون نهاد مالی (وام غیرمجاز)
- تنزیل ۱۰۰ درصد اسمی بدون ذخیره کسورات
- پرداخت به بیمار یا اعتبار مصرف‌کننده

۷. رقبا و تمایز

گزینه موجود	چه می‌کند	شکاف نسبت به دارونقدی
وام بانکی سنتی	تسهیلات با رتبه اعتباری، ضامن، وثیقه	به نسخه بیمه وصل نیست؛ کند و عمومی است
وام کارتخوان	بر اساس گردش شاپرک	فروش بیمه‌ای در پوز دیده نمی‌شود
سامانه فکتورینگ وزارت اقتصاد	واگذاری مطالبات قراردادی	UX پیمانکاری؛ نسخه روزانه داروخانه را پوشش نمی‌دهد
اسناد گام / برات الکترونیک	تأمین مالی زنجیره تولید	بیشتر به بنگاه تولیدی و پخش می‌خورد تا داروخانه محله
لندتک و BNPL	اعتبار خرد مصرف‌کننده	مسئله قفسه و بیمه را حل نمی‌کند
نرم‌افزارهای داروخانه	انبار، نسخه، حسابداری	پول نمی‌آورند؛ شریک کانال ما هستند نه رقیب

موضع‌گیری: دارونقدی «یک وام دیگر» نیست. تنها محصولی است که واحد اقتصادی‌اش **نسخه تأییدشده بیمه‌گر پایه** است و خروجی‌اش برای مشتری، پاس شدن چک پخش است. نزدیک‌ترین تهدید، واحد SCF خود بانک است؛ دفاع ما داده عمودی و توزیع از طریق پخش و نرم‌افزار داروخانه است.

۸. مسیر قانونی و شرکای کلیدی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و دستورات عمل پذیرش مطالبات قراردادی (فکتورینگ) بانک مرکزی، واگذاری طلب به نهاد مالی را به رسمیت شناخته است. دارونقدی باید روی همین ریل حرکت کند، نه روی مدل «صندوق خانوادگی» یا پرداختیاری.

موضوع	موضع پیشنهادی
ماهیت حقوقی	شرکت فناوری / عامل معرفی شده بانک؛ نه مؤسسه اعتباری
منبع پول	صرفاً بانک، مؤسسه اعتباری یا نهاد فکتورینگ مجاز
قرارداد داروخانه	واگذاری/خرید دین + رضایت به واریز بیمه در حساب معرفی شده
داده نسخه	با رضایت داروخانه و در چارچوب قرارداد بیمه؛ حداقل داده لازم
مبارزه با تقلب	رد نسخه تکراری، داروخانه پرریسک، الگوی غیرعادی اقلام
آنچه ممنوع است	جذب وجوه عموم، تضمین سود، تبلیغ «وام بدون ضامن» جدا از بانک

شرکای اجباری قبل از مقیاس

- یک بانک عامل با سهمیه فکتورینگ یا SCF و حساب اختصاصی وصول.
- یک نرم افزار داروخانه برای خواندن دوره بیمه بدون ورود دستی.
- مشاور حقوقی سلامت + بانکی برای قالب قرارداد سه جانبه.
- انجمن داروسازان استان برای اعتماد صنفی، نه الزاماً سهم مالکیت.

تا نامه بانک عامل و نمونه قرارداد سه جانبه آماده نشود، جذب سرمایه جدی نباید قفل شود به «ایده»؛ باید قفل شود به پایلوت حقوقی.

۹. ورود به بازار

فروش مستقیم درب به درب به ۱۸ هزار داروخانه در سال اول غلط است. کانال باید جایی باشد که داروخانه همین امروز پول و دارو را از آن می گیرد.

اولویت	کانال	چرا
۱	شرکت نرم افزار داروخانه	یک اتصال، صدها پنل؛ داده نسخه از قبل آنجاست
۲	شرکت پخش	پخش ذی نفع وصول است؛ اگر چک پاس شود سهمیه می دهد
۳	انجمن داروسازان استان تهران	اعتماد صنفی و معرفی ۲۰ داروخانه پایلوت
۴	بانک عامل، شعب سلامت محور	داروخانه های دارای حساب نزد همان بانک

پیام فروش به هر مخاطب

به پخش: «داروخانه طرف حسابت نقد می شود؛ برگشتی چک کم می شود و سهمیه معطل نمی ماند.»

به داروساز: «قفسهات خالی نماند و چک پخش برگشت نخورد. طلب تأیید شده بیمه را ۴۸ ساعته نقد می کنیم.»

به انجمن: «ابزار بقا برای داروخانه کوچک، نه رقیب زنجیره ها.»

به بانک: «دارایی پایه، طلب بیمه گر حاکمیتی است نه سفته شخص. ما داده نسخه و کسورات را برایت می خوانیم.»

جغرافیا: تهران (تراکم، نزدیکی به بیمه ها و پخش)، سپس اصفهان و مشهد. داروخانه شبانه روزی پرتراфик برای داستان موفقیت بهتر است از داروخانه کم نسخه.

۱۰. نقشه راه و تیم

۹۰ روز پایلوت (قبل از مقیاس)

ماه	خروجی الزامی	معیار عبور
ماه ۱	اتصال داده ۲۰ داروخانه؛ هنوز بدون پول	وضعیت نسخه در ۸۰ درصد موارد خوانا باشد
ماه ۲	اولین خرید دین روی نسخ تأییدشده تأمین اجتماعی	حداقل ۱۰ تراکنش واقعی با سقف محدود
ماه ۳	تطبیق واریز بیمه یا ذخیره کسورات؛ گزارش نجات چک	رضایت کتبی ۱۰ داروخانه و ادامه بانک

۱۲ ماه پس از پایلوت

- ۱۵۰ داروخانه فعال در تهران
- افزودن بیمه سلامت به صورت قیمت‌گذاری جدا
- ماژول چک پخش در استفاده هفتگی حداقل ۶۰ درصد مشتریان
- شروع اصفهان با همان بانک یا بانک دوم

تیم حداقلی بذر

نقش	چرا حیاتی است
مدیرعامل با نفوذ صنفی یا بانک سلامت	بدون اعتماد داروساز، داده نمی‌آید
مسئول محصول داده نسخه / بک‌اند	موتور بسته‌بندی طلب
عملیات داروخانه (ترجیحاً داروساز)	کسورات و زبان قفسه
ریسک و اعتبار (خروجی از بانک)	سقف، ذخیره، تقلب
حقوقی پاره‌وقت بانکی-سلامت	قرارداد سه‌جانبه

۱۱. سناریوی مالی (محافظه کارانه)

اعداد زیر برای جهت دهی است، نه پیش بینی حسابرسی شده. فرض پایه: متوسط تنزیل ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر داروخانه فعال، سهم پلتفرم ۰/۶ درصد مبلغ اسمی (علاوه بر کارمزد بانک که جدا به بانک می رسد)، و اشتراک خالص فقط روی بخشی از مشتریان.

سال ۳	سال ۲	سال ۱ (پس از پایلوت)	
۹۰۰	۴۵۰	۱۵۰	داروخانه فعال (میانگین پایان سال)
۱,۶۲۰ میلیارد تومان	۸۱۰ میلیارد تومان	۲۷۰ میلیارد تومان	حجم تنزیل سالانه (تقریبی)
۹/۷ میلیارد تومان	۴/۹ میلیارد تومان	۱/۶ میلیارد تومان	درآمد سهم پلتفرم از تنزیل
۱/۸ میلیارد تومان	۰/۹ میلیارد تومان	۰/۳ میلیارد تومان	درآمد اشتراک پنل
۱۱/۵ میلیارد تومان	۵/۸ میلیارد تومان	۱/۹ میلیارد تومان	جمع درآمد تقریبی

نکته سرمایه گذار

این مدل نیاز به سرمایه برای «وام دادن» ندارد؛ نیاز به سرمایه برای ساخت موتور داده و عملیات دارد. محدودیت رشد، سقف بانک عامل و کیفیت وصول است نه بودجه بازاریابی گسترده.

هزینه اصلی سال اول

- تیم ۶ تا ۸ نفره
- اتصال و انطباق داده
- حقوقی و ذخیره عملیاتی کسورات
- فروش میدانی محدود تهران

اگر بانک سهم origination را کمتر از ۱۵ درصد کارمزد بدهد، مدل باید با اشتراک بالاتر و خدمات پخش جبران شود. این حساسیت باید در ترم شیت بانک دیده شود.

۱۲. ریسک‌ها، کنترل‌ها و درخواست

ریسک	شدت	کنترل
کسورات و رد نسخه	بالا	فقط نسخه تأییدشده؛ ذخیره تاریخی؛ سقف ماهانه
توقف طولانی پرداخت یک بیمه‌گر	بالا	سقف درگیری هر سازمان؛ تنوع سلامت و نیروهای مسلح از ماه ۶
قفل شدن داده نسخه	بالا	چند منبع: نرم‌افزار داروخانه + فایل دوره + ورود کنترل‌شده
خروج بانک عامل	بالا	قرارداد با SLA و بانک دوم از ماه ۹
تفسیر رگولاتوری به‌عنوان وام غیرمجاز	متوسط	عدم تبلیغ تسهیلات مستقل؛ پول فقط از نهاد مجاز
تقلب نسخه‌ای / داروخانه صوری	متوسط	پایش اقلام، مقایسه صنفی، احراز فیزیکی پایلوت
اختلاط دارویار با سهم فنی	متوسط	جداسازی کامل ردیف‌ها در محصول

معیارهای کشتن ایده (اگر رخ داد، توقف)

- پس از ۶۰ روز نتوان وضعیت تأیید نسخه را از منبع معتبر خواند.
- بانک عامل تا پایان ماه ۲ به تراکنش واقعی نرسد.
- کسورات واقعی بیش از دو برابر ذخیره مدل در سه دوره متوالی باشد.

درخواست از مخاطب این سند

1. تأیید پایلوت ۹۰ روزه با سقف محدود و ۲۰ داروخانه تهران.
2. معرفی یا همراهی برای انتخاب بانک عامل و نشست حقوقی قرارداد سه‌جانبه.
3. در صورت تمایل سرمایه‌گذار: سرمایه بذر متمرکز بر محصول و عملیات، نه بر ترازنامه وام.

سه پیام پایانی

1. درد واقعی است و امروز با اعداد همتی در سطح ملی دیده می‌شود.
2. محصول مشابه عمودی برای نسخه داروخانه در بازار ایران وجود ندارد.
3. بدون بانک عامل و داده نسخه، این ایده شرکت نمی‌شود؛ با آن دو، یک زیرساخت سلامت است.

دارونقدی — پروپوزال کسب‌وکار — شهریور ۱۴۰۵. منابع: انجمن داروسازان ایران، گزارش‌های مهر و رسانه‌های سلامت (تیر و مرداد ۱۴۰۵)، چارچوب فکتورینگ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد. این سند توصیه سرمایه‌گذاری قطعی نیست و باید با بررسی حقوقی و داده پایلوت تکمیل شود.